



GUIA GRATUITO · WEBINÁRIO ITH

Guia de bolso das **6 metas internacionais** de segurança do paciente

Por que cada barreira funciona, onde a equipe mais erra, como medir e um checklist de auditoria pronto para usar.



WEBINÁRIO COM

Esp. Juliana Dias

Embaixadora do MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente

POR QUE AS METAS FUNCIONAM

Erro não é falta de cuidado. É falta de barreira.

As metas internacionais reúnem os pontos da assistência em que o erro é mais frequente e mais grave. No Brasil, conversam com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (Portaria MS nº 529/2013), com a RDC ANVISA nº 36/2013 e com os protocolos básicos do Ministério da Saúde.

A lógica por trás delas é o **modelo do queijo suíço** (James Reason): todo processo tem "furos" (cansaço, interrupção, nomes parecidos, pressa). O dano acontece quando os furos de várias camadas se alinham. Cada meta acrescenta uma camada de proteção que não depende da memória ou da atenção de uma única pessoa.

CASO ILUSTRATIVO · SITUAÇÃO COMPOSTA A PARTIR DE OCORRÊNCIAS COMUNS, COM DADOS FICTÍCIOS**Dois "José" na mesma enfermaria**

Plantão noturno, enfermaria com 6 leitos. José Carlos (leito 3) e José Roberto (leito 4) têm prescrições de anticoagulante em doses diferentes. A técnica prepara a dose do leito 3, é chamada para uma intercorrência e, ao voltar, administra a medicação no "José do leito 4" conferindo apenas o número do leito. O paciente recebe a dose errada e apresenta sangramento no dia seguinte.

O que falhou: identificação pelo leito (furo 1), interrupção durante o preparo (furo 2), ausência de conferência da pulseira com dois identificadores (furo 3) e anticoagulante sem dupla checagem, apesar de ser medicamento de alta vigilância (furo 4). A meta 1 sozinha, cumprida, teria barrado o erro.

Como usar este guia: na próxima página estão as seis metas com a barreira principal, o erro mais comum e o porquê. Na página 4, um checklist para auditar o seu setor.

AS 6 METAS NA PRÁTICA

Barreira, erro comum e porquê

Meta	Barreira principal	Erro mais comum	Por que a barreira funciona
1. Identificar o paciente	Pulseira com 2 identificadores (nome completo + data de nascimento), conferida antes de todo procedimento	Identificar pelo leito ou perguntar "o senhor é o João?"	Leito muda e o paciente confuso diz "sim". Pedir que ele diga o nome e conferir com a pulseira não depende de memória
2. Comunicação efetiva	Passagem de plantão estruturada (SBAR) e leitura de volta em ordens verbais e resultados críticos	Passagem de plantão "de corredor", sem roteiro	Roteiro fixo impede que a informação crítica dependa de quem lembra de falar
3. Medicamentos de alta vigilância	Lista institucional, sinalização no estoque e dupla checagem independente	"Dupla checagem" em que o segundo profissional só olha a seringa já pronta	Duas pessoas calculando separadamente raramente cometem o mesmo erro
4. Cirurgia segura	Checklist da OMS nos 3 momentos: sign in, time out, sign out	Time out feito com o cirurgião já com o bisturi na mão, como formalidade	A pausa obriga a equipe inteira a confirmar paciente, procedimento e lado em voz alta
5. Reduzir infecções	Higiene das mãos nos 5 momentos da OMS, com álcool no ponto de assistência	Higienizar só depois do contato ("para me proteger") e esquecer o antes	O "antes" protege o paciente; álcool à beira do leito elimina a desculpa da distância da pia
6. Quedas e lesão por pressão	Avaliação de risco (Morse e Braden) na admissão e periódica, com plano de cuidado por faixa de risco	Aplicar a escala, registrar a pontuação e não mudar nenhum cuidado	A escala só protege quando a pontuação aciona uma conduta (grade, cama baixa, mudança de decúbito)

CÁLCULO RESOLVIDO

Higiene das mãos e quedas no mês

Adesão à higiene das mãos = oportunidades com higiene ÷ oportunidades observadas × 100

= 109 ÷ 168 × 100 = **64,9%**

Densidade de quedas = nº de quedas ÷ pacientes-dia × 1.000

= 4 ÷ 2.350 × 1.000 = **1,70 queda por 1.000 pacientes-dia**

Leitura: um terço das oportunidades ficou sem higiene. Cruze com o "momento" observado; quase sempre a falha concentra-se no momento 1 (antes de tocar o paciente).

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Checklist de auditoria das 6 metas · beira de leito

Setor: _____ Data: _____ Leito: _____

Auditor: _____

#	Item verificado	Sim	Não	N/A
1	Paciente com pulseira legível, com nome completo e data de nascimento	☐	☐	☐
2	Profissional confere a pulseira antes de medicar ou coletar (observado)	☐	☐	☐
3	Passagem de plantão registrada no instrumento padronizado (SBAR)	☐	☐	☐
4	Ordem verbal registrada com leitura de volta, quando houve	☐	☐	☐
5	Medicamentos de alta vigilância sinalizados e separados no posto	☐	☐	☐
6	Registro de dupla checagem nos medicamentos de alta vigilância administrados	☐	☐	☐
7	Checklist de cirurgia segura completo nos 3 momentos (pacientes cirúrgicos)	☐	☐	☐
8	Preparação alcoólica disponível no ponto de assistência	☐	☐	☐
9	Higiene das mãos realizada antes do contato com o paciente (observado)	☐	☐	☐
10	Escala de Morse aplicada e registrada no prazo	☐	☐	☐
11	Conduta de prevenção de queda compatível com a pontuação (grade, cama baixa e travada)	☐	☐	☐
12	Escala de Braden aplicada e plano de mudança de decúbito em uso	☐	☐	☐

Conformidade do leito = itens "Sim" ÷ (itens aplicáveis) × 100 = ____ %. Some todos os leitos auditados para a conformidade do setor.



PRÓXIMO PASSO

Quer aprofundar este tema ao vivo?

Este guia resume os pontos centrais. No webinar gratuito com a Esp. Juliana Dias, você vê os exemplos da rotina e tira suas dúvidas no chat.

Webinário gratuito: As 6 metas internacionais de segurança do paciente

Online e ao vivo. Inscreva-se e receba a data e o link no WhatsApp e no e-mail.

Quero me inscrever grátis

mkt.faculdadeith.com.br/lp/webinario-metas-seguranca-paciente/

MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente - 100% EAD

Controle de infecção, gestão de riscos, acreditação e núcleo de segurança do paciente. 440 horas, diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5).

Conhecer o MBA

Fontes

- Ministério da Saúde. Portaria nº 529/2013 e Protocolos Básicos de Segurança do Paciente.
- ANVISA. RDC nº 36/2013.
- Joint Commission International. International Patient Safety Goals.
- Reason J. Human error: models and management. BMJ, 2000.
- OMS. Cirurgias Seguras Salvam Vidas; Os 5 momentos para a higiene das mãos.